4 Intervention Mapping

Lernziele

Nach der Lektüre dieses Kapitels

- kennen Sie die Grundlagen von Intervention Mapping und Sie wissen, wie beim Intervention Mapping verschiedene wissenschaftliche Erkenntnisse in Gesundheitsinterventionen integriert werden,
- können Sie die sechs Schritte im Intervention Mapping sowie die Hauptaufgaben der jeweiligen Schritte benennen,
- sind Sie in der Lage auf Basis vorliegender Informationen und Ergebnisse ein logisches Modell des Problems, der Veränderung und der Intervention abzuleiten,
- kennen Sie den Unterschied zwischen Verhaltenszielen, Handlungszielen und Veränderungszielen und sind in der Lage, diese auf der Grundlage der Ergebnisse aus einer Bedarfsanalyse zu formulieren,
- können Sie theoriebasierte Methoden für die Verhaltensänderung identifizieren und diese unter Berücksichtigung ihrer Wirkparameter in praktische Anwendungen übersetzen,
- kennen Sie das Vorgehen, Programmmaterialien und -komponenten zu entwickeln und können aus diesen eine Gesundheitsintervention erstellen,
- können Sie Annehmende und Umsetzende der Intervention identifizieren und Verhaltens- und Handlungsziele für diese formulieren,
- wissen Sie, was bei der Evaluation von Gesundheitsinterventionen berücksichtigt werden muss und können Evaluationsdesigns bewerten,
- können Sie begründen, warum eine Dokumentation der Interventionsentwicklung wichtig ist und wissen, inwiefern Intervention Mapping hierfür eine Grundlage bietet.

Nicht immer entspricht der Ist-Zustand in Bezug auf die Gesundheit dem Soll-Zustand. Wenn dies der Fall ist, werden Gesundheitsförderungsprogramme oder -interventionen benötigt. Solche Programme sind am wirksamsten, wenn sie auf der Grundlage von Theorien und empirischen Befunden entwickelt und nachfolgend adäquat implementiert werden. Zur Qualitätssicherung sollten Programme zur Gesundheitsförderung gründlich evaluiert werden. Um den Prozess der Entwicklung von theorie- und evidenzgestützten Gesundheitsinterventionen zu strukturieren, wurde Intervention Mapping entwickelt. Intervention Mapping – und ebenso andere daran anknüpfende Ansätze (Michie et al., 2014) - ist ein Protokoll für die Planung, Umsetzung und Evaluation von Gesundheitsförderungsprogrammen (Bartholomew Eldredge et al., 2016). Dabei wird davon ausgegangen, dass Gesundheit zu einem Großteil das Ergebnis von Verhalten ist. Daher werden bei der Entwicklung von gesundheitsbezogenen Interventionen theoriegestützte Determinanten, die das Verhalten beeinflussen, adressiert (Peters, 2014).

4.1 Grundlagen von Intervention Mapping

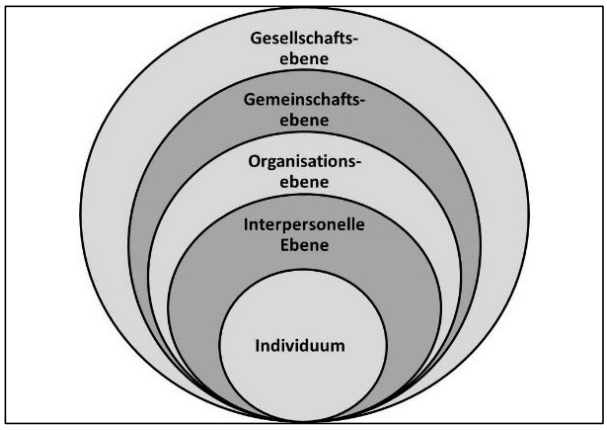
Beim Intervention Mapping wird *theorie- und evidenzorientiert* gearbeitet (Bartholomew & Mullen, 2011). Das bedeutet, dass zur Lösung eines Gesundheitsproblems verschiedene Theorien angewandt werden. Eine einzelne Theorie reicht häufig nicht aus, um komplexes Verhalten zu erklären und darauf eine Intervention zu basieren. Außerdem werden beim Intervention Mapping aktuelle Forschungsergebnisse einbezogen und falls Forschungslücken identifiziert werden, wird eigene Forschung durchgeführt.

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

Intervention Mapping betrachtet Probleme aus einer *ökologischen Perspektive*. Das bedeutet, dass Individuen nicht in einem Vakuum leben, sondern in ein System mit verschiedenen Ebenen eingebettet sind (siehe Abbildung 4.1). Aus dieser Perspektive betrachtet, ist Gesundheit das Ergebnis von Interaktionen und Beziehungen zwischen den verschiedenen Ebenen. Gesundheitsprogramme müssen sich daher nicht nur auf das Verhalten des Individuums richten, sondern auch auf das Verhalten von Agierenden auf den jeweiligen Ebenen (engl.: environmental agents). Agierende auf den Umweltebenen sind Personen, die nicht persönlich vom Gesundheitsproblem betroffen sind, die jedoch ihr Verhalten ändern müssen, um so die Verhaltensänderung von Betroffenen zu ermöglichen beziehungsweise zu vereinfachen. Auf der interpersonellen Ebene können das zum Beispiel Personen aus dem Freundeskreis oder Kollegium oder Familienmitglieder sein, auf der Organisationsebene Führungskräfte oder Vorgesetzte, auf der Gemeindeebene Personen aus der Lokalpolitik und auf der Gesellschaftsebene Personen aus der nationalen oder internationalen Politik.

Abbildung 4.1

Schema des ökologischen Ansatzes in Gesundheitsförderungsprogrammen. Nach Bartholomew Eldredge et al., 2016, S. 9



Bei allen Schritten von der Planung über die Entwicklung und Implementierung zur Evaluation sollten die Zielgruppe sowie wichtige Agierende auf den Umweltebenen die Möglichkeit zur *Partizipation* bekommen. Partizipation ist unverzichtbar, damit das Programm sich wichtigen Anliegen der Allgemeinheit widmet, um eine große Breite an Wissen, Fähigkeiten und Expertise einzubringen und um die externe Validität zu verbessern. Außerdem wird durch Partizipation gewährleistet, dass die zuständigen Agierenden die Intervention annehmen, umsetzen und positiv bewerten (Bartholomew Eldredge et al., 2016).

4.1.1 Die sechs Schritte im Intervention Mapping

Intervention Mapping besteht aus sechs Schritten. Das Endprodukt des vorhergehenden Schrittes begründet dabei jeweils den Ausgangspunkt des nächsten Schrittes. Auch wenn die Schritte aufeinander aufbauen, ist der Prozess in der Praxis selten linear, sondern das Entwicklungsteam bewegt sich immer wieder zwischen den Schritten hin und her. Das Wesentliche ist, dass zuletzt kein Schritt vernachlässigt wurde. In Tabelle 4.1 werden die sechs Schritte des Intervention Mapping im Überblick dargestellt.

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

Tabelle 4.1

Überblick über die sechs Schritte des Intervention Mappings. Nach Bartholomew Eldredge et al., 2016

Schritt	Aufgaben	Schlüsselfragen
1. Bedarfsanalyse (engl.: Needs and Assets Assessment)	• Zusammenstellen einer Entwicklungsgruppe • Überblick über das Problem verschaffen (Logisches Modell des Problems, siehe Abbildung 4.2) • Erfassen der Stärken und Ressourcen der Zielgruppe (engl.: community capacity) • Bewertung von Verhaltens- und Umweltfaktoren • Formulierung des Interventionsziels	• „Was ist das Problem?" • „Warum ist es ein Problem?" • „Was verursacht das Problem?" • „Für wen ist es ein Problem?"
Ergebnisse aus Schritt 1	Genaue Beschreibung des Problems, seiner Ursachen und seines Einflusses auf die Lebensqualität	
2. Erstellen von Programmzielen (engl.: Intervention Outcomes and Objectives)	• Übersetzung der problemerzeugenden und -aufrechterhaltenden in problemreduzierende Verhaltensweisen und Umweltbedingungen • Formulierung von Verhaltenszielen • Identifikation von Umweltzielen • Ableitung konkreter Handlungsziele (engl.: performance objectives) • Bestimmung kausaler Determinanten der Handlungsziele • Formulierung von Veränderungszielen (engl.: change objectives) zur Veränderung der Determinanten • Identifikation von Subgruppen der Interventionspopulation	• „Wie kann das Problem gelöst werden?" • „Wer muss was tun?" • „Warum sollte diese Person das tun?"
Ergebnisse aus Schritt 2	Matrizen zu Handlungszielen, deren Determinanten und dazugehörigen Veränderungszielen	
3. Auswahl theoriebasierter Methoden und Anwendungen (engl.: Methods and Practical Implications)	• Brainstorming und Auswahl theoriebasierter Methoden und Anwendungen • Vollständige Zuordnung von Methoden und Anwendungen zu Veränderungszielen unter Berücksichtigung methodenspezifischer Wirkparameter	• „Wie und unter welchen Bedingungen können die angezielten Veränderungen umgesetzt werden?"
Ergebnisse aus Schritt 3	Instrumentarium von Methoden und Anwendungen, die sich auf den interventionsspezifischen Kontext anwenden lassen	
4. Programmentwicklung (engl.: Intervention Design and Production)	• Zusammenfassung aller Einzelkomponenten zu Gesamtprogramm unter Berücksichtigung von Zielgruppe und Kontext • Entwicklung von Programmideen • Entwurf und Testung der Materialien	• „Wie sieht das Gesamtbild der Intervention aus?" • „Welche Materialien werden verwendet?"
Ergebnisse aus Schritt 4	Ausgearbeitete Intervention für den vorliegenden Kontext	
5. Annahme und Umsetzung des Programms (engl.: Implementation Mapping)	• Identifikation der Personen, die für Annahme und Umsetzung des Programms zuständig sind • Entwurf von Zielmatrizen (analog zu Schritt 2) für Annehmende und Umsetzende	• „Wie können Annehmende und Umsetzende des Programms von dessen Annahme, bzw. Durchführung überzeugt werden?"
Ergebnisse aus Schritt 5	Detaillierter Plan zur Überzeugung Interventionsannehmender und -umsetzender Personen	
6. Evaluationsplan (engl.: Evaluation Plan)	• Wahl des Evaluationsdesigns • Evaluation der Effekte und des Prozesses der Intervention	• „Wurden die Interventionsziele erreicht?" • „Welcher Effekt kann in Bezug auf die Lebensqualität und Gesundheit der Zielgruppe verzeichnet werden?" • „Wurde das Programm adäquat entwickelt, eingeführt und durchgeführt?"
Ergebnisse aus Schritt 6	Bewertung der Effekt- und Prozessevaluation als Basis für fortlaufende Anpassung und ggf. Reevaluation der Intervention	

4.1.2 Anwendung logischer Modelle im Intervention Mapping

In der Interventionsforschung wird üblicherweise mit logischen Modellen gearbeitet (Fernandez et al., 2019). Das heißt, es werden Modelle über kausale Zusammenhänge von Determinanten und Verhaltensänderungen aufgestellt und als Grundlage für die

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

Interventionsplanung und -evaluation genutzt. Mithilfe von logischen Modellen kann also die genaue Wirkweise einer Intervention Schritt für Schritt nachvollzogen werden. Die Kausalität der Modelle ist hierbei von links nach rechts gerichtet, bei der Erstellung der Modelle dient hingegen der Endzustand als Startpunkt und es wird rückwärts – also von rechts nach links – gearbeitet. Im folgenden Video wird die Nutzung von logischen Modellen bei der Interventionsentwicklung im Allgemeinen erklärt.

Video 4.1. Logic models, theory of change and program evaluation (Elane Mandie). Verfügbar unter https://youtu.be/lYi30bL0AMo

Beim Intervention Mapping werden drei verschiedene logische Modelle verwendet, die unterschiedliche Perspektiven annehmen: die Logik des Problems, die Logik der Veränderung und die Logik der Intervention. Dabei wird in Schritt 1 (siehe Abschnitt 4.2 „Bedarfsanalyse“) zuerst das *logische Modell des Problems* erstellt (siehe Abbildung 4.2). Dieses Modell stellt dar, was das Problem ist und welche Determinanten mit dem Problem zusammenhängen. Um zu begreifen, was verändert werden soll, muss zuerst verstanden werden, was das Problem ist und welche Faktoren dazu beitragen. Von Schritt 1 zu Schritt 2 (siehe Abschnitt 4.3 „Erstellen von Programmzielen“) erfolgt demnach ein Perspektivenwechsel von der Logik des Problems zur Logik der Veränderung. Im zweiten Schritt wird das *logische Modell der Veränderung* (siehe Abbildung 4.3) erstellt. Das heißt, dieses Modell zeigt auf, was sich konkret verändern muss, um die gewünschte Veränderung zu erzielen.

Abbildung 4.2

Logisches Modell des Problems. Nach Bartholomew Eldredge et al., 2016, S. 227

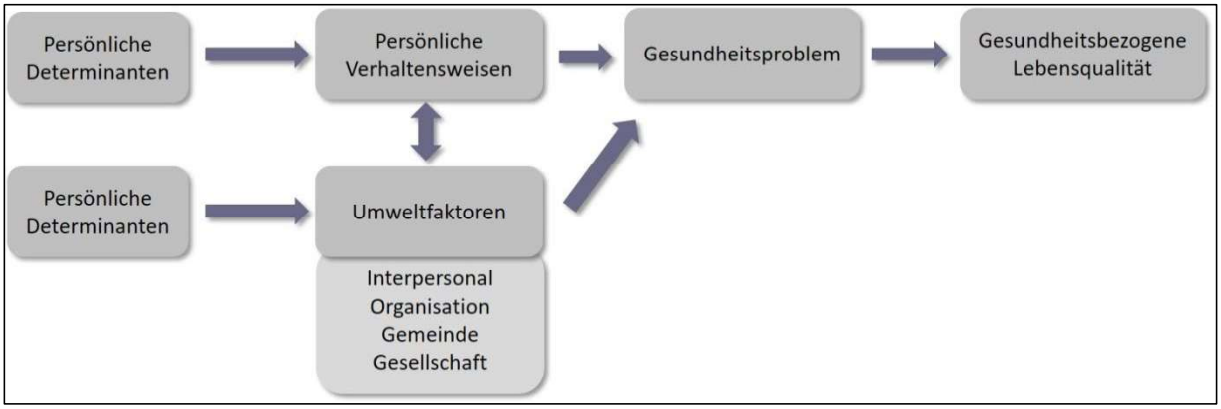
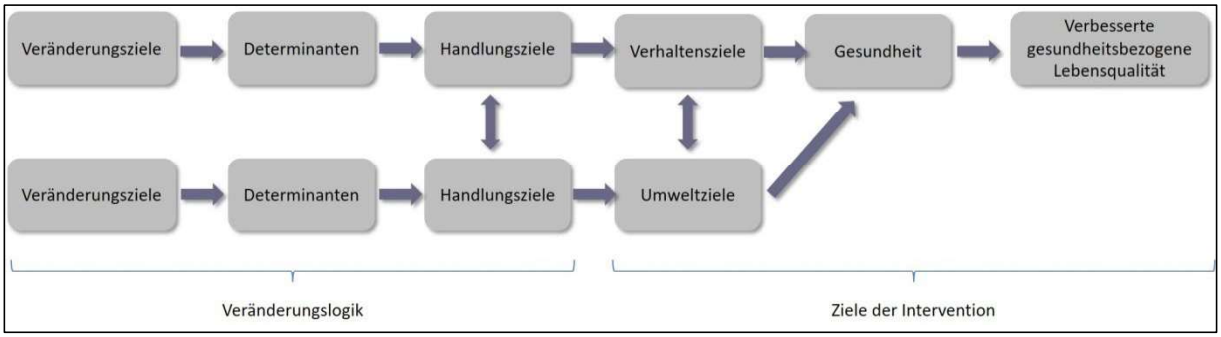


Abbildung 4.3

Logisches Modell der Veränderung. Aus Bartholomew Eldredge et al., 2016, S. 285

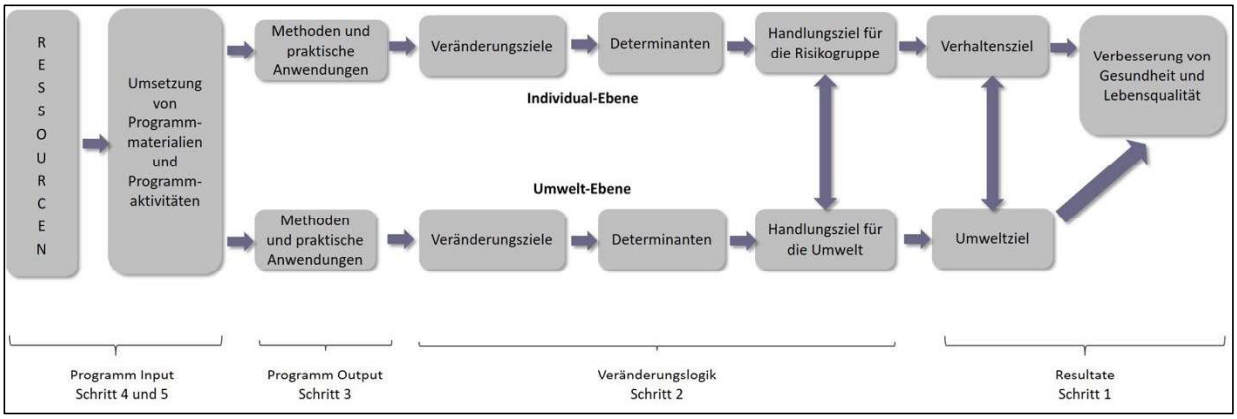


Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

Das *logische Modell der Intervention* (siehe Abbildung 4.4) zeigt die Logik der Intervention insgesamt. Hierbei handelt es sich um theoretisch begründete Annahmen über kausale Zusammenhänge zur Funktionsweise der Intervention. Wenn die Intervention gut entwickelt und in allen Schritten sorgsam gearbeitet wurde, sollte also jeder Schritt im logischen Modell der Intervention sukzessiv zu einer Verbesserung des Problemzustands führen. Das logische Modell der Intervention enthält sowohl das logische Modell des Problems (Ergebnisse von Schritt 1) als auch das logische Modell der Veränderung (Bestandteil von Schritt 2). Außerdem umfasst es weiterhin die in Schritt 3 identifizierten Methoden und praktischen Anwendungen, sowie die in Schritt 4 und 5 formulierten Pläne zur Implementierung und konkreten Umsetzung des Programms. In Schritt 6 wird das logische Modell der Intervention genutzt, um die genaue Wirkweise der Intervention zu evaluieren und Drehpunkte zur Anpassung der Intervention zu identifizieren.

Abbildung 4.4

Logisches Modell der Intervention. Nach Bartholomew Eldredge et al., 2016, S. 547



4.1.3 Schlüsselprozesse zum Anwenden von Theorie und empirischen Befunden

Um zu einem möglichst vollständigen Verständnis des Problems zu gelangen und eine effektive Intervention zu entwickeln, werden beim Intervention Mapping bei jedem Schritt sechs Schlüsselprozesse angewendet (Crutzen & Nalukwago, 2026):

- Planungsfragen stellen,
- „Brainstorming" von vorläufigen Antworten auf die Planungsfragen,
- die Literatur nach Belegen durchsuchen und deren Güte bewerten,
- die Literatur nach Theorien durchsuchen, diese bewerten und auf das Problem anwenden,
- Forschung durchführen, um Antworten auf unbeantwortete Fragen zu finden,
- eine Liste von Antworten auf die Planungsfragen zusammenstellen.

Jeder Schritt wird mit den für ihn spezifischen Fragen begonnen. Auf diese Fragen werden beim „Brainstorming" vorläufige Antworten gefunden. Hierbei kann Erfahrung oder Vorwissen von allen Mitgliedern der Entwicklungsgruppe eingebracht werden. So gelangt man zu einem breiten Spektrum an relevanten Antworten. Die resultierenden Ideen werden in einem vorläufigen Erklärungsmodell festgehalten. Erst danach wird vorhandene Literatur herangezogen. Zunächst wird nach empirischen Belegen und anschließend nach für das Problem relevanten Theorien gesucht.

An die Suche nach Theorien kann man auf unterschiedliche Arten herangehen. Zunächst kann die Literatur thematisch nach spezifischen Theorien durchsucht werden. Diese Herangehensweise wird als *problemgerichtete Herangehensweise* (engl.: issue approach) bezeichnet. Zum Beispiel

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

kann nach spezifischen Theorien zum Thema „Aktives Mobilitätsverhalten" gesucht werden. Dabei könnte man unter anderem auf das Rahmenmodell für aktives Mobilitätsverhalten von Götschi et al. (2017) (siehe Kurs 3, Kapitel 7 „Planetary Health") stoßen. Hieraus können dann weitere Faktoren, die zum Problem beitragen, extrahiert werden. Die zweite Herangehensweise ist die *konstruktgerichtete Herangehensweise* (engl.: construct approach). Dazu werden relevante Konzepte, die während des Brainstormings genannt wurden, als theoretische Konstrukte formuliert. Diese theoretischen Konstrukte werden dann tiefreichender recherchiert. Wenn zum Beispiel während des Brainstormings das Konzept „andere Personen verhalten sich gesundheitsschädlich" genannt wurde, kann das Konstrukt „soziale Norm" tiefreichender recherchiert werden. Diese Recherche kann weitere hilfreiche Informationen über die Konstrukte hervorbringen, wie zum Beispiel, dass bei Verhaltensänderungen häufig subjektive Normen eine Rolle spielen und dass diese sich aus der normativen Erwartung und der Motivation der Erwartungserfüllung zusammensetzen (Ajzen, 1985). Als dritte Variante können allgemeine Theorien auf das Problem angewendet werden, beispielsweise die sozial-kognitive Theorie (Bandura, 1986). Diese Herangehensweise wird als *theoriegerichtete Herangehensweise* (engl.: general theory approach) bezeichnet.

Nach der Literaturrecherche lassen sich weitere Konzepte zum Erklärungsmodell hinzufügen und vorhandene Konzepte verfeinern. Zur Klärung unbeantworteter Fragen kann das Entwicklungsteam schließlich eigene Forschung durchführen. Abschließend werden eine endgültige Liste der Antworten und ein endgültiges Erklärungsmodell erstellt, sowie die identifizierten Determinanten nach Relevanz (Stärke der Assoziation) und Veränderbarkeit (Beeinflussbarkeit) geordnet.

4.2 Schritt 1: Bedarfsanalyse

Im einfachsten Sinne besteht Bedarf, wenn eine messbare Lücke zwischen dem Ist- und dem Sollzustand besteht (Altschuld & Watkins, 2014). Im Fall der Bedarfsanalyse für Gesundheitsinterventionen wird der jetzige Zustand mit einem wünschenswerteren Zustand in Bezug auf Gesundheit und Lebensqualität verglichen. Einbezogen werden physiologische Faktoren und Verhaltensrisikofaktoren ebenso wie Umweltrisikofaktoren. Letztendlich werden Determinanten, das heißt Ursachen für das Risikoverhalten und Umweltrisikofaktoren, bestimmt. Während der Bedarfsanalyse entsteht ein möglichst genaues und detailliertes Bild des Problems. Neben dem Bedarf werden bei der Bedarfsanalyse auch vorhandene Stärken und Ressourcen der Zielgruppe analysiert.

Um eine umfassende Bedarfsanalyse durchzuführen, wird beim Intervention Mapping wie folgt vorgegangen:

Zusammenstellen einer Entwicklungsgruppe

Der erste Schritt in der Bedarfsanalyse ist die Zusammenstellung einer Entwicklungsgruppe, um Partizipation zu ermöglichen und vielfältige Kenntnisse und Perspektiven einzubringen. Diese sollte aus verschiedenen für die Intervention relevanten Personen bestehen. So sollten Expert:innen aus unterschiedlichen relevanten Fachrichtungen Teil der Entwicklungsgruppe sein, ebenso wie Personen, die direkt oder indirekt vom Programm betroffen sein werden. Wichtig sind außerdem Autoritäten, die die Programmentwicklung beziehungsweise -durchführung steuern oder die über Ressourcen beziehungsweise gesellschaftlichen oder politischen Einfluss verfügen. Des Weiteren kann es hilfreich sein, Vertreter:innen verschiedener Interessengruppen zum Thema einzubeziehen. Der Beginn eines neuen Schrittes ist ein guter Zeitpunkt, um die Entwicklungsgruppe zu reevaluieren und gegebenenfalls neue Mitglieder hinzuzufügen.

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

Erstellen des logischen Modells des Problems

Als Nächstes wird ein logisches Modell des Problems erstellt (siehe Abbildung 4.2). Dafür muss das Problem zunächst eingegrenzt und genau definiert werden. Im logischen Modell des Problems werden das zu untersuchende Gesundheitsproblem und sein Einfluss auf die Lebensqualität sowie die das Problem beeinflussenden Verhaltens- und Umweltfaktoren mit den jeweils dazugehörigen Determinanten dargestellt. Es werden also Ursachen auf der individuellen sowie den verschiedenen Umweltebenen berücksichtigt.

Beim Erstellen des logischen Modells des Problems wird von Gesundheitsproblemen (z. B. Übergewicht, kardiovaskuläre Erkrankungen, sexuell übertragbare Krankheiten) oder unerwünschten Verhaltensweisen (z. B. Rauchen, ungeschütztem Geschlechtsverkehr, ungesunder Ernährung) ausgehend gearbeitet. Dabei ist es zunächst wichtig, die Population, die vom Gesundheitsproblem betroffen ist, beziehungsweise das unerwünschte Verhalten ausübt, genau zu erfassen. Es können demografische Charakteristiken, Gesellschaftscharakteristiken, besonders belastete Populationssegmente und spezielle Risikofaktoren betrachtet werden. Außerdem führen Entwickler:innen Prävalenzraten und mit dem Gesundheitsproblem einhergehende Risiken auf.

Darauf folgt eine Analyse, welche Verhaltensweisen und Umweltfaktoren das Gesundheitsproblem wie beeinflussen. Beispielsweise wird das Gesundheitsproblem „sexuell übertragbare Krankheiten" unter anderem durch die Verhaltensweisen „kein Kondom beim Geschlechtsverkehr verwenden" und „wechselnde Sexualpartner:innen" begünstigt. Ein Beispiel für einen begünstigenden Umweltfaktor könnte sein: „Kondome sind nicht unmittelbar verfügbar". Danach wird nach Determinanten für die Verhaltensweisen und Umweltfaktoren gesucht. Determinanten sind Faktoren, die das Gesundheitsverhalten beziehungsweise die Umweltfaktoren direkt beeinflussen. Häufig sind sie kognitiver Natur (Peters, 2014). Einige Beispiele für Determinanten für das Risikoverhalten „kein Kondom während des Geschlechtsverkehrs verwenden" sind die Einstellung, dass Kondome sich nicht gut anfühlen („Einstellung"), Unsicherheit über korrekte Anwendung von Kondomen („Selbstwirksamkeit") und die Wahrnehmung, dass andere Gleichaltrige kein Kondom verwenden („subjektive Norm").

Erfassen von Stärken und Kapazitäten der Zielgruppe

Altschuld und Watkins (2014) argumentieren, dass bei der Bedarfsanalyse Gesundheitsprobleme nicht ausschließlich aus einer defizitären Perspektive betrachtet werden dürfen, sondern auch bereits vorhandene Stärken und Kapazitäten berücksichtigt werden müssen. Diese können individuell oder bezogen auf die Zielgruppe als Ganzes betrachtet werden. Beispiele sind sozialer Zusammenhalt, vorhandene Kommunikationsstrukturen, meinungsführende Personen, aber auch finanzielle Ressourcen, Räumlichkeiten oder vorhandene Infrastruktur. So wird sichergestellt, dass der einzigartige Charakter von Zielgruppen in die Entwicklung der Intervention einfließt und dass die Intervention nicht ausschließlich von außerhalb gesteuert wird. Zudem wird durch die Stärkung bereits vorhandener Strukturen und die Nutzung vorhandener Ressourcen die Nachhaltigkeit des Programms gefördert.

Bewertung von Verhaltens- und Umweltfaktoren

Die zuvor identifizierten Verhaltens- und Umweltfaktoren werden anschließend bezüglich ihrer Relevanz und Veränderbarkeit bewertet. Relevantere Faktoren erhalten folglich eine höhere Priorität und Faktoren, die weniger relevant und weniger veränderbar sind, können in der Intervention eher untergeordnet berücksichtigt werden.

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

Formulieren des Zieles der Intervention

Letztendlich wird das Ziel der Intervention formuliert. Ziele von Interventionen beziehen sich üblicherweise auf das spezifische Verhalten, die Lebensqualität oder die Gesundheit. Wichtig ist hierbei, mithilfe von empirischen Grundlagen genau zu definieren, was sich in der Zielpopulation um wie viel in welcher Zeitspanne verändern soll. Ziele sollten so spezifisch wie möglich formuliert und messbar sein, um die Evaluation zu vereinfachen. Beispiele für gute Programmziele sind: „Innerhalb von drei Jahren wird im Schulbezirk xy der Anteil der Schüler:innen in den Klassenstufen 7–10, der mit dem Rauchen beginnt, um 15 % gesenkt." und „Innerhalb der nächsten fünf Jahre wird der Anteil übergewichtiger Kindergartenkinder in Nordrhein-Westfalen auf 12 % reduziert."

4.3 Schritt 2: Erstellen von Programmzielen

Im zweiten Schritt wird das Problem aus einer lösungsorientierten Perspektive betrachtet. Also erfolgt an dieser Stelle ein Wechsel der Betrachtungsweise von der Logik des Problems zur Logik der Veränderung. Die im Rahmen der Bedarfsanalyse gewonnenen Informationen und ausgearbeiteten Programmziele dienen als Basis, um Verhaltensziele und Umweltziele zu formulieren. Darauf aufbauend werden konkrete Handlungsziele (engl.: performance objectives) ausgearbeitet. Durch eine Kreuzung der Handlungsziele mit ihren jeweiligen Determinanten ergeben sich die Matrizen der Veränderungsziele (engl.: change objectives). Definitionen von Verhaltens-, Handlungs- und Veränderungszielen, sowie Determinanten finden Sie in Kasten 4.1.

Verhaltensziel. Ein Verhaltensziel beschreibt, welche Verhaltensweise von der Zielgruppe beziehungsweise den Agierenden auf den jeweiligen Umweltebenen als Ergebnis der Intervention erwartet wird.

Handlungsziel. Ein Handlungsziel spezifiziert, was die Zielgruppe beziehungsweise die Agierenden auf den jeweiligen Umweltebenen tun muss beziehungsweise müssen, um das Verhaltensziel zu erreichen.

Determinanten. Determinanten sind Faktoren, die in kausalem Zusammenhang mit den Handlungszielen stehen.

Veränderungsziel. Ein Veränderungsziel beschreibt, wie genau sich die Determinanten verändern müssen, um die Handlungsziele zu erreichen.

Kasten 4.1. Definitionen von Verhaltensziel, Handlungsziel, Determinanten und Veränderungsziel.

Laut dem Modell der Veränderung (siehe Abbildung 4.3) führt das Erreichen der Veränderungsziele zu Änderungen der Determinanten. Die Determinanten wiederum beeinflussen das Erreichen der Handlungsziele. Diese ermöglichen das Erfüllen der Verhaltens- und Umweltziele. Das Erreichen dieser führt zu verbesserter Gesundheit und dadurch zu verbesserter Lebensqualität.

Um die einzelnen Programmziele in Verhaltensziele, Handlungsziele und Veränderungsziele aufzuschlüsseln, müssen die folgenden Aufgaben bearbeitet werden:

Formulieren von Verhaltenszielen

Verhaltensziele werden als Verhaltensweisen, die aus der Intervention resultieren sollen, formuliert. Während der Bedarfsanalyse werden üblicherweise risikofördernde Verhaltensweisen identifiziert, jedoch ist es bezogen auf die Entwicklung einer Intervention hilfreicher, sich auf gesundheitsfördernde Verhaltensweisen zu fokussieren. Darum müssen die risikofördernden

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

Verhaltensweisen aus der Bedarfsanalyse zunächst in risikomindernde, gesundheitsfördernde oder Selbstmanagement- und Compliance-Verhaltensweisen übersetzt werden.

Risikomindernde Verhaltensweisen reduzieren bereits vorhandene Risiken (z. B. mit dem Rauchen aufhören reduziert das Risiko, an Lungenkrebs zu erkranken). *Gesundheitsfördernde Verhaltensweise*n verbessern die Gesundheit beziehungsweise schützen vor Krankheit (z. B. Zähne putzen, ausreichend Schlaf). *Compliance- und Selbstmanagement-Verhaltensweisen* beziehen sich auf bereits Erkrankte. Sie verbessern den Umgang mit der Krankheit und beugen einer Verschlimmerung des Zustandes vor (z. B. Diabetespatient:innen beobachten ihren Blutzuckerspiegel; siehe auch Kurs 1, Kapitel 2 „Gesundheitsbezogenes Verhalten").

Auch im Hinblick auf die Evaluation ist es wichtig, Verhaltensziele spezifisch und messbar zu formulieren. Zum Beispiel wurde in der Bedarfsanalyse ungeschützter Sex als Risikoverhalten für sexuell übertragbare Krankheiten festgestellt. Dieses Risikoverhalten kann in das folgende Verhaltensziel übersetzt werden: „immer ein Kondom beim Geschlechtsverkehr benutzen".

Identifizieren von Umweltzielen

Während der Bedarfsanalyse wurden neben individuellen Risikofaktoren auch Umweltbedingungen, die individuelle Verhaltensweisen oder das Gesundheitsproblem direkt beeinflussen, identifiziert. Daher sollten zusätzlich zu Verhaltenszielen auch Umweltziele formuliert werden. Umweltziele bezeichnen die in der Umwelt notwendigen Veränderungen. Das Beispiel aus dem vorherigen Abschnitt fortführend, müssen in der Umwelt Möglichkeiten vorhanden sein, Kondome zu beschaffen, damit das Individuum ein Kondom benutzen kann. Ein Umweltziel auf der Organisationsebene wäre beispielsweise: „In Bars stehen Kondomautomaten zur Verfügung".

Unterteilung von Verhaltens- und Umweltzielen in Handlungsziele

Verhaltens- und Umweltziele sind breite Konzeptualisierungen und sind nicht detailliert genug, um auf ihnen eine Intervention zu basieren. Daher werden Handlungsziele benötigt, um zu konkretisieren, was getan werden muss, um ein Verhaltensziel zu erreichen. Sie sind untergeordnete Verhalten des Verhaltenszieles. Das heißt, sie beschreiben detailliert, was getan werden muss. Oft sind Handlungsziele eine Abfolge von Einzelschritten der Verhaltensziele. Beispielsweise muss man, um ein Kondom beim Geschlechtsverkehr benutzen zu können, 1. „Kondome kaufen", 2. „Kondome bei sich tragen", 3. „mit dem/der Partner:in über die Verwendung eines Kondoms sprechen" und 4. „das Kondom korrekt überziehen". Für Handlungsziele auf einer Umweltebene muss konkretisiert werden, *wer was* tun muss, um das Umweltziel zu erreichen. Damit in Bars Kondomautomaten zur Verfügung stehen, muss das Barmanagement 1. „Kondomautomaten anbringen", 2. „Kondomautomaten regelmäßig warten" und 3. „Kondomautomaten regelmäßig auffüllen".

Auswahl relevanter und veränderbarer Determinanten

Die Bedarfsanalyse hat eventuell bereits einige Determinanten, die das Risikoverhalten erzeugen, aufgezeigt. Üblicherweise müssen diese allerdings weiter spezifiziert und an das gewünschte Verhalten angepasst werden. Dafür bieten die zuvor formulierten Handlungsziele eine gute Grundlage. Fragen, die man sich typischerweise stellt, um Determinanten zu erfassen sind: „Warum sollte jemand das gesundheitsfördernde Verhalten beziehungsweise Handlungsziel ausführen?" und „Warum sollten Agierende auf den Umweltebenen Modifizierungen vornehmen?". Üblicherweise beinhalten Determinanten kognitive Faktoren (z. B. Einstellung,

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

Wissen, Erwartungen) sowie Fähigkeiten und Fertigkeiten. Von diesen Determinanten werden die relevanten und veränderbaren für die Intervention verwendet.

Unterteilen der Interventionspopulation

Möglicherweise bestehen innerhalb einer Zielgruppe für die Intervention relevante Unterschiede. Oft können Subgruppen identifiziert werden, wenn festgestellt wird, dass sich Determinanten oder Handlungsziele innerhalb der Zielgruppe unterscheiden. Zum Beispiel könnte man feststellen, dass bei weiblichen Jugendlichen die Angst vor einer möglichen Schwangerschaft eine wichtige Determinante für die Verwendung von Kondomen ist, die bei männlichen Jugendlichen eher weniger relevant ist, oder es könnte bemerkt werden, dass sich rauchende Personen in unterschiedlichen Stadien des transtheoretischen Modells (Prochaska & Velicer, 1997; siehe auch Kurs 1, Kapitel 6 „Gesundheitsverhaltensmodelle") befinden. Während die einen sich noch in der Präkontemplationsphase befinden und noch nicht darüber nachdenken, mit dem Rauchen aufzuhören, sind andere bereits einige Schritte weiter und planen mit dem Rauchen aufzuhören. Die Gruppe der rauchenden Personen in der Präkontemplationsphase muss zunächst realisieren, dass sie mit dem Rauchen aufhören sollte, wohingegen dieser Schritt bei rauchenden Personen in der Planungsphase nicht mehr relevant ist. Aufgrund solcher Unterschiede ist es manchmal sinnvoll, die Zielgruppe zu unterteilen. Jede der identifizierten Subgruppen benötigt dann eine separate Matrix der Veränderungsziele. Mögliche Unterteilungen können zum Beispiel nach Geschlecht, Alter oder Erfahrung erfolgen. Manchmal sind auch Unterteilungen aufgrund von Stufenmodellen sinnvoll. Aus praktischen Gründen sollte das Entwicklungsteam jedoch immer die Vorteile einer Unterteilung der Zielgruppe gegen die Kosten und Umstände verschiedener Interventionen abwägen (siehe auch Video 4.2).

Erstellen von Matrizen der Veränderungsziele

Um eine Matrix der Veränderungsziele zu erstellen, werden Handlungsziele mit Determinanten gekreuzt. Für die Zielgruppe und die Agierenden der verschiedenen Umweltebenen, für die zuvor Verhaltens- und Handlungsziele formuliert wurden, wird jeweils eine eigene Matrix der Veränderungsziele erstellt. Handlungsziele werden in die linke Spalte eingetragen und Determinanten in die obere Zeile. In die jeweiligen Zellen werden die dazugehörigen Veränderungsziele eingetragen, das heißt, was sich konkret in den Determinanten verändern muss, um die Handlungsziele zu erreichen. Sollte eine Determinante auf ein bestimmtes Handlungsziel keinen Einfluss haben, ist es möglich, die dazugehörige Zelle leer zu lassen. Das Ergebnis ist eine Matrix, bestehend aus Veränderungszielen, Handlungszielen und Determinanten (siehe Tabelle 4.2).

Tabelle 4.2

Schematischer Aufbau einer Matrix aus Veränderungs-, Handlungszielen und Determinanten

Übergeordnetes Verhaltens-/Umweltziel für die Personengruppe XY		
	Determinante A	**Determinante B**
Handlungsziel A	Veränderungsziel A/A	Veränderungsziel A/B
Handlungsziel B	-	Veränderungsziel B/B

4.4 Schritt 3: Auswahl von theoretischen Methoden und Anwendungen

Die Hauptaufgabe im dritten Schritt ist es, theoriebasierte Methoden auszuwählen, um die zuvor definierten Programmziele zu erreichen. Diese Methoden müssen in praktische Anwendungen übersetzt werden. Hierbei gilt es, die Wirkparameter der Methode zu

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

berücksichtigen. Daher wird beim Intervention Mapping strukturiert von theoretischen Methoden zu praktischen Anwendungen gearbeitet. Die Definitionen von Methoden, Anwendungen und Wirkparametern finden Sie in Kasten 4.2.

Methode. Methoden sind allgemeine theoriebasierte Techniken oder Prozesse, die das Verhalten der Zielgruppe oder der Agierenden auf den Umweltebenen beeinflussen. Sie sind generisch und über Populationen, Kulturen und Verhaltensdomänen generalisierbar.

Anwendung. Anwendungen sind die Übersetzungen der Methoden in praktische Interventionselemente. Idealerweise sind sie spezifisch und auf die Intervention zugeschnitten.

Wirkparameter. Wirkparameter sind die Charakteristika, die eine Anwendung berücksichtigen muss, um die Methode richtig zu übersetzen. Falls Parameter nicht eingehalten werden, ist die Effektivität der Methode nicht gewährleistet.

Kasten 4.2. Definitionen von Methode, Anwendung und Wirkparameter.

Es gibt Methoden, um individuelle Determinanten zu verändern und Methoden für die Veränderung von Umweltfaktoren (Kok et al., 2016). Zum Beispiel ist „angeleitete Übung" eine Methode, um Fähigkeiten und Selbstwirksamkeit zu verbessern. Ein Beispiel für eine Methode auf der interpersonellen Ebene ist das Stärken von Bindungen des sozialen Netzwerks, um soziale Unterstützung zu verbessern. Methoden für die Veränderung von Umweltfaktoren bestehen häufig aus mehreren Methoden, die auf bestimmte Determinanten abzielen (Kok et al., 2012). Die von Kok et al. (2016) vorgeschlagene Taxonomie von Verhaltensänderungsmethoden bietet eine gute Grundlage, um Methoden und Wirkparameter für bestimmte Determinanten zu identifizieren. Hier sind übersichtlich Methoden und Wirkparameter nach Determinanten sortiert dargestellt. Daher eignet sie sich nicht nur zur Kategorisierung von Methoden, sondern auch zur Erstellung und Evaluation von Interventionen.

Ein typischer und schwerwiegender Fehler in der Programmplanung ist, bei der Übersetzung von Methoden zu Anwendungen die Wirkparameter zu vernachlässigen (Peters et al., 2015; Peters et al., 2013) wie es zum Beispiel bei der Anwendung von Schreckbildern auf Zigarettenpackungen geschehen ist (siehe Kasten 4.3).

Abbildung 4.5

Furchtappell auf Zigarettenpackung. Aus Europäische Union, 2014



Seit 2016 muss jede Zigarettenverpackung eine grafische Warnung über mögliche Gesundheitsfolgen tragen (Richtlinie 2014/40/EU; Europäische Union, 2014). Der Grundgedanke hierbei ist, Menschen durch das Hervorrufen von negativen Emotionen vom Rauchen abzuschrecken (siehe auch Kurs 1, Kapitel 6 „Gesundheitsverhaltensmodelle"). Problematisch ist jedoch, dass es nicht ausreicht, angsteinflößende Information zu präsentieren, um Verhalten zu ändern, sondern dass Personen auch eine hohe Selbstwirksamkeitserwartung haben müssen. Peters et al. (2013) raten daher, Furchtappelle nur zu verwenden, wenn die Selbstwirksamkeit der

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

Zielgruppe hoch ist. Bei Personen, die rauchen, ist das in Bezug auf die Rauchentwöhnung jedoch häufig nicht der Fall, besonders da es sich um Suchtverhalten handelt. Außerdem lösen angsteinflößende Nachrichten häufig eine defensive Reaktion aus. Das bedeutet, die empfangenden Personen leugnen das Risiko, ignorieren die Nachricht oder verarbeiten die Information verzerrt. Die empfangende Person muss daher überzeugt werden, dass sie persönlich für die negativen Konsequenzen anfällig ist. Darin liegt ein weiteres Problem der Schreckbilder auf Zigarettenpackungen, denn sie zeigen kein personalisiertes Risiko. Schreckbilder allein erhöhen weder die Selbstwirksamkeit noch die wahrgenommene persönliche Anfälligkeit für das Gesundheitsrisiko. Zusammengefasst wurden die Wirkparameter (hohe Selbstwirksamkeit, hohe Handlungswirksamkeit und persönliche Anfälligkeit) der Methode Furchtappelle nicht berücksichtigt.

Kasten 4.3. *Beispiel für einen Fehler bei der Übersetzung von Methoden zu Anwendungen.*

Die Identifikation passender Methoden und Anwendungen erfordert verschiedene Arbeitsschritte:

Brainstormen von Methoden und Anwendungen

Bei der Auswahl von Methoden und Anwendungen kann unterschiedlich vorgegangen werden. Mitglieder der Entwicklungsgruppe haben wahrscheinlich bereits einige Ideen, wie eine Intervention aussehen könnte. Entwickler:innen können daraus die praktischen Anwendungen extrahieren und überprüfen, ob diese zu den formulierten Programmzielen passen, auf welchen theoretischen Methoden sie fußen und ob sie die Wirkparameter der jeweiligen Methode berücksichtigen. Andererseits können die Entwickler:innen strukturiert zu den Programmzielen und Determinanten passende Methoden suchen und diese unter Berücksichtigung der Wirkparameter in Anwendungen übersetzen. Ein wiederum anderer Ansatz ist es, über Methoden und Anwendungen, unter Prüfung der Wirkparameter, gleichzeitig zu brainstormen. Welche Arbeitsweise gewählt wird, hängt vom bevorzugten Arbeitsstil der Entwicklungsgruppe ab. Das Wichtigste ist, dass am Ende des Schrittes theoretische Methoden, unter Berücksichtigung ihrer Wirkparameter, korrekt in praktische Anwendungen umgewandelt wurden und dass die zuvor identifizierten Determinanten durch die Methoden adressiert werden.

Auswahl spezifischer Methoden und Anwendungen

Um theoretische Methoden zu identifizieren, ist es hilfreich, zunächst die Veränderungsziele nach Determinanten zu ordnen. Danach werden den jeweiligen Determinanten passende Methoden zugeordnet. Es ist gut möglich, dass mehrere Methoden verwendet werden können, um eine bestimmte Determinante zu ändern. Zum Beispiel kann die Determinante Wissen mithilfe der Methoden Diskussionen, Elaboration und gegebenen Hinweisen verändert werden. Es ist auch möglich, dass eine Methode verschiedene Determinanten adressiert. Zum Beispiel kann die Methode Diskussion, neben der Determinante Wissen, auch die Determinante Einstellung verändern. Bei der Auswahl von Anwendungen ist es wichtig, die Wirkparameter der jeweiligen Methode zu berücksichtigen. Die Methode Modeling hat ihren Ursprung beispielsweise in der sozial-kognitiven Theorie (Bandura, 1986). Diese stellt die Parameter der Methode dar, nämlich: dem Model muss Aufmerksamkeit geschenkt werden und es muss in Erinnerung bleiben; das Individuum muss die nötigen Fähigkeiten und Selbstwirksamkeit besitzen, das Verhalten auszuführen; das Model muss für sein Verhalten belohnt werden und das Individuum muss sich mit dem Model identifizieren. Außerdem muss das Modell ein Coping Model anstatt eines Mastery Models sein. Das heißt, das gewünschte Verhalten darf ihm nicht zu leichtfallen, sondern das

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

Model muss mit gewissen Hürden konfrontiert werden (Kok et al., 2016). Die Kunst hierbei ist es, die Methoden so zu kombinieren, dass alle Determinanten adressiert werden, und bei der Übersetzung in praktische Anwendungen die Wirkparameter zu berücksichtigen. Zum Beispiel muss, wenn festgestellt wurde, dass nicht nur Einstellung eine relevante Determinante ist, sondern auch fehlende Selbstwirksamkeit, die Methode Modeling mit einer weiteren Methode (z. B. angeleitete Übung) kombiniert werden, um auch die Selbstwirksamkeit zu verbessern.

Überprüfung, ob jedem Veränderungsziel eine Methode und praktische Anwendung zugeordnet wurde

Üblicherweise werden in einer Intervention verschiedene Methoden und Anwendungen kombiniert. Zuletzt ist es wichtig, zu überprüfen, ob die gewählten Anwendungen alle Veränderungsziele abdecken. Falls die Entwickler:innen hierbei feststellen, dass sie ein bestimmtes Veränderungsziel noch nicht adressieren, können sie entweder bereits vorhandene Methoden und Anwendungen so anpassen, dass das Veränderungsziel eingeschlossen wird oder erneut nach passenden Methoden und Anwendungen suchen.

4.5 Schritt 4: Programmentwicklung

Im vierten Schritt müssen zunächst Programmmaterialien und -komponenten ausgearbeitet und entwickelt werden. Die meisten Gesundheitsprogramme bestehen aus vielen verschiedenen Komponenten. Es ist erlaubt und sogar erwünscht, bei der Entwicklung kreativ zu werden. Die besondere Herausforderung bei diesem Schritt ist, die Programmmaterialien so zu entwickeln, dass die Methoden und Anwendungen korrekt instrumentalisiert werden. Das bedeutet, dass auch bei der Entwicklung der Materialien die Wirkparameter einer Methode berücksichtigt werden müssen. Außerdem müssen die Materialien und Komponenten an die Zielgruppe sowie an die Umsetzenden angepasst werden. Das bedeutet zum Beispiel, dass bei einer schulbasierten Intervention nur dann Rollenspiele eingesetzt werden sollten, wenn Lehrende (Umsetzende) und Lernende (Zielgruppe) kompetent in dieser Methodik sind oder in der Lage und motiviert sind, diese zu erlernen. Weiterhin macht die Entwicklung einer App nur dann Sinn, wenn die Zielgruppe über ein Smartphone verfügt und mit der Verwendung von Apps zu verschiedenen Themen vertraut ist.

Um die verschiedenen Aspekte bei der Programmentwicklung zu berücksichtigen, müssen in diesem Schritt bestimmte Aufgaben erledigt werden:

Entwickeln von Programmideen

Die erste Aufgabe zur Programmentwicklung ist es, gemeinsam mit der Zielgruppe Ideen über ein angebrachtes Programmdesign bezüglich Struktur, Medium und Kontext zu sammeln. Danach werden Programmideen entwickelt. Es müssen Entscheidungen über den Umfang und den Ablauf getroffen werden. Der *Umfang* einer Intervention beschreibt die Menge und Intensität eines Programms (z. B. ob es intensiv in einer kurzen Periode oder regelmäßig über einen langen Zeitraum durchgeführt wird), während der *Ablauf* der Intervention die Reihenfolge der Module und Komponenten beschreibt und ob diese parallel oder nacheinander ablaufen. Weiterhin müssen Kommunikationskanäle und Kommunikationsvehikel gewählt werden. Ein *Kommunikationskanal* ist das Kommunikationsmedium, durch welches die Nachricht überbracht wird (z. B. Fernsehen, persönlichen Kontakt oder gedruckten Text). Ein *Kommunikationsvehikel* beschreibt, auf welche Art eine Nachricht verpackt und überbracht wird (z. B. Interview, Nachrichten, Talkshow für das Fernsehen, Lehrende, Eltern oder Krankenpflegepersonal für persönlichen Kontakt und Artikel oder Reportage für gedruckten Text). Bei der Auswahl sollte

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

berücksichtigt werden, welche Medien die Zielgruppe verwendet, wie sie diese verwendet und welchen Einfluss diese ausüben beziehungsweise auf welche Art Mitglieder der Zielgruppe zu welchen Themen bevorzugt kommunizieren. Zum Beispiel sehen sich Jugendliche im Fernsehen andere Programme an, die zu anderen Zeiten laufen, und sie lesen andere Zeitschriften als Hausfrauen. Zusätzlich üben diese Medien einen anderen Einfluss auf Jugendliche aus. Zudem beeinflusst die Auswahl der Methoden, welche Kanäle und Kommunikationsvehikel sich anbieten. Zum Beispiel eignet sich ein Radiointerview nicht, um die Methode angeleitete Übung anzuwenden, oder die Methode Individualisierung lässt sich über Fernsehprogramme nicht realisieren. Das bedeutet, dass auch hier die Parameter der ausgewählten Methoden berücksichtigt werden müssen.

Viele Interventionen werden entlang eines *Themas* entwickelt. Beispiele für Themen sind „Komm mit in das gesunde Boot" (Wartha et al., 2016) für eine Gesundheitsförderungsintervention in einem Kindergarten oder „The gay cruise" (Kok et al., 2006) für eine Intervention, die homosexuelle Männer vor sexuell übertragbaren Krankheiten schützen soll. Die Zielgruppe wird mithilfe des Themas an die Interventionsziele herangeführt und Materialien und Komponenten werden entlang des Themas entwickelt. Die Intervention „The gay cruise" spielt sich beispielsweise auf einer virtuellen Kreuzfahrt ab, auf der unterschiedliche Aufgaben mit Bezug auf das Sexualverhalten gelöst werden müssen. Des Weiteren kann es hilfreich sein, bereits existierende Programmmaterialien, die zu den Programmzielen passen, zu sichten. Hierbei muss jedoch genau geprüft werden, ob diese Materialien für die Zielgruppe geeignet sind und ob sie zu den gewählten Methoden mit den jeweiligen Wirkparametern passen. Vor der Verwendung bereits existierender Materialien ist in jedem Fall das Urheberrecht zu klären.

Produktion von Programmmaterialien

Der nächste Schritt ist die Produktion von Programmmaterialien. Selten verfügen Interventionsentwickler:innen hierfür über das nötige Fachwissen. Daher werden zu diesem Zweck üblicherweise externe Fachkräfte (z. B. Schauspieler:innen, Programmierer:innen, Grafikdesigner:innen etc.) angestellt. Da diese für gewöhnlich nicht über Fachwissen in der Entwicklung von Interventionen verfügen, ist es wichtig, ihnen die relevanten Aspekte (Methoden, Wirkparameter, Zielgruppe, etc.) genau zu kommunizieren und nach der Produktion Methoden und Wirkparameter erneut zu überprüfen. Zum Beispiel könnte ein:e Drehbuchautor:in zur Skripterstellung eines Clips angestellt werden, der ein Vorbild bezüglich der Rauchentwöhnung bei Jugendlichen darstellen soll. Diese Drehbuch-Fachkraft weiß normalerweise nicht, dass ein wichtiger Wirkparameter der Methode ist, dass das Model ein Coping Model sein muss (und auch nicht, was ein Coping Model ist). Das heißt, dass eine gute Kommunikation mit den externen Fachkräften notwendig ist, damit das Endergebnis sowohl professionell erstellt als auch passend für die Interventionsmethoden ausfällt.

Prätest und Pilotversuch

Zuletzt werden der Prätest der einzelnen Komponenten und der Pilotversuch des Programms durchgeführt. Beim *Prätest* stehen die Einzelteile der Intervention im Vordergrund. Vorgetestet werden einzelne Konzepte, wie Phrasen und Visualisierungen, auf Verständlichkeit, Lesbarkeit, Ästhetik sowie ob die gewünschte Nachricht überbracht wurde. Die einzelnen Komponenten werden auch bezüglich des Effektes auf die Determinanten bewertet. Außerdem sollte überprüft werden, inwieweit die einzelnen Komponenten als vorteilhaft gegenüber bereits vorhandenen Materialien und Interventionskomponenten empfunden werden und wo potenzielle Schwierigkeiten in der Umsetzung liegen. Gegebenenfalls müssen im Anschluss Komponenten

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

ausgetauscht, angepasst oder verfeinert werden. Beim *Pilotversuch* wird das komplette Programm von Umsetzenden und Teilnehmenden getestet. Hierbei geht es vorrangig darum, zu klären, wie reibungslos das Programm als Ganzes durchzuführen ist, und potenzielle Schwierigkeiten zu identifizieren.

4.6 Schritt 5: Annahme und Umsetzung des Programms

Der fünfte Schritt ist für den Erfolg der Intervention unverzichtbar. In diesem Schritt geht es darum, die Annehmenden und Umsetzenden von der Durchführung des Programms zu überzeugen. Bereits in den Schritten 1 bis 4 wurden Annehmende und Umsetzende in der Entwicklungsgruppe einbezogen. Diese Partizipation kann sich bereits positiv auf die Akzeptanz des Programms auswirken. Zusätzlich widmen sich die Entwickler:innen in Schritt 5 direkt der Annahme und Umsetzung des Programms.

Folgend wird dargestellt, wie in Schritt 5 vorzugehen ist, um für die Annahme und Umsetzung des Programms zu planen:

Identifizieren von Annehmenden und Umsetzenden

Die erste wichtige Aufgabe ist zu identifizieren, wer für die Annahme (engl.: adoption) und Umsetzung (engl.: implementation) der Intervention zuständig ist. Über den Kontext der Intervention wurden in vorherigen Schritten bereits Entscheidungen getroffen. Nun muss geklärt werden, welche Personen in diesem Kontext die Entscheidungskraft besitzen, die Intervention einzuführen. Diese Personen sind die Annehmenden. Umsetzende sind diejenigen, die die Intervention letztendlich durchführen. Wenn zum Beispiel eine Intervention in einer Schule geplant wird, müssen die Schulbehörde und die Schulleitung (Annehmende) das Programm annehmen und in das Kurrikulum einführen. Sie setzen das Programm aber nicht selber um, sondern delegieren diese Aufgabe an die jeweiligen Lehrkräfte oder externe Fachkräfte (Umsetzende). Für eine erfolgreiche und nachhaltige Intervention (engl.: sustainability) ist daher eine enge Vernetzung mit den Annehmenden und Umsetzenden von hoher Bedeutung.

Erstellen von Zielen für die Annahme, Umsetzung und Nachhaltigkeit des Programms

Die nächste Aufgabe ist es, Verhaltens- und Handlungsziele für die Annehmenden und Umsetzenden zu erstellen. Das Verhaltensziel „Umsetzung" alleine genügt für eine wirksame Intervention nicht. Stattdessen müssen die Methoden und Strategien korrekt, vollständig und in angemessener Dosis (bezogen auf die Anzahl und das Ausmaß der Einheiten) angewandt werden und das Programm langfristig umgesetzt werden. Diese Anforderungen übersetzen sich in die in diesem Schritt verfolgten Programmziele *Annahme* („Annehmende entscheiden sich, das Programm zu übernehmen"), *korrekte und vollständige Umsetzung/Umsetzungsgenauigkeit* („Umsetzende führen das Programm mit allen dazugehörigen Einheiten korrekt durch") und *Nachhaltigkeit* („Umsetzende integrieren das Programm in die Alltagsabläufe/das Kurrikulum").

Um Handlungsziele zu formulieren, werden die Programmziele in Einzelschritte aufgeteilt. Die Frage hierbei lautet: „Was müssen Annehmende (bzw. Umsetzende) tun, um das Programm anzunehmen (bzw. richtig und vollständig umzusetzen und in die Alltagsroutine einzubauen)?". Anschließend werden Determinanten für die Handlungsziele gesucht. Aus den Handlungszielen und Determinanten werden drei Matrizen gebildet, eine für die Annahme, eine für die Umsetzung und eine für Nachhaltigkeit. Ebenso wie in Schritt 3, werden im Anschluss Methoden bezogen auf die Determinanten ermittelt. Das bedeutet, dass letztendlich ein eigenständiges Programm für Annahme, Umsetzung und Nachhaltigkeit entwickelt wird. Hierbei gilt es, die gleichen Faktoren

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

wie in Schritt 4 zu berücksichtigen. Zusammengefasst durchlaufen Entwickler:innen in Bezug auf Annahme, Umsetzung und Nachhaltigkeit erneut die Schritte 1 bis 4 des Intervention Mappings.

4.7 Schritt 6: Evaluation des Programms

Der letzte Schritt beim Intervention Mapping ist die Entwicklung eines Evaluationsplans. Kontinuierliche Evaluation ist notwendig, um das Programm weiterentwickeln und anpassen zu können (siehe Kurs 2, Kapitel 5 „Evaluation gesundheitspsychologischer Maßnahmen“).

Um die verschiedenen Aspekte, die bei der Evaluation von Gesundheitsmaßnahmen relevant sind, zu berücksichtigen, führt das Entwicklungsteam beim Intervention Mapping eine Anzahl von Aufgaben aus, die nachfolgend erklärt werden. Ausführliche Informationen zum Thema Evaluation von Gesundheitsmaßnahmen finden Sie auch in Kurs 2, Kapitel 5 „Evaluation“.

4.7.1 Evaluationsarten

Bei der Programmevaluation können im Wesentlichen zwei verschiedene Herangehensweisen voneinander differenziert werden: die Effekt- und die Prozessevaluation. Wird der Effekt der Intervention auf Gesundheit und Lebensqualität bewertet, sowie ob Verhaltensziele, Handlungsziele und Veränderungsziele erreicht und Determinanten verändert wurden, spricht man von einer Effektevaluation. Mithilfe der Prozessevaluation wird hingegen der gesamte Prozess bewertet. Es wird also festgestellt, wie gut das Programm entwickelt, eingeführt und durchgeführt wurde. Beide Evaluationstypen können miteinander kombiniert werden und schließen sich gegenseitig nicht aus.

Effektevaluation

Zunächst wird das Erreichen der Programmziele bewertet (Effektevaluation). Das heißt: „Um wie viel hat sich das Gesundheitsproblem in der festgelegten Zeitspanne verändert?“, „Um wie viel hat sich die Lebensqualität in der festgelegten Zeitspanne verändert?“ und „Wie haben sich Verhalten und Umweltkonditionen in der festgelegten Zeitspanne verändert?“. Dafür muss zuerst ein realistischer Zeitrahmen festgelegt werden, in dem Effekte erwartet werden. Effekte in Bezug auf Gesundheit und Lebensqualität sind häufig erst nach mehreren Jahren messbar und werden daher üblicherweise erst in einem langfristigen Follow-up ersichtlich. Folglich werden zunächst Handlungsziele, Verhaltensziele und Umweltziele evaluiert, um so schrittweise dem logischen Modell der Veränderung zu folgen. Das heißt, dass zunächst geprüft wird, ob die Zielgruppe alle Verhaltensweisen, die sie ausführen soll, nach Abschluss der Intervention tatsächlich ausführt. Der Gedanke hierbei ist, dass sich diese Verhaltensweisen langfristig positiv auf die Gesundheit und Lebensqualität der Zielgruppe auswirken sollten, wenn die Theorie der Veränderung sorgfältig entwickelt wurde. Einerseits kann eine Evaluation der Handlungs- und Verhaltensziele durch Beobachtung geschehen. Andererseits sind Fragebögen beruhend auf Selbsteinschätzung von Verhalten oder Intention gute Indikatoren. Optimal ist eine Kombination verschiedener Erhebungsmethoden (siehe Kurs 2, Kapitel 3 „Forschungsmethoden in der Gesundheitspsychologie“). Außerdem wird bewertet, inwiefern sich die Determinanten verändert haben. Um eine Veränderung der Determinanten zu messen, können die Veränderungsziele herangezogen werden. So können zu jedem Veränderungsziel eine bis zwei Fragen formuliert werden. Daher war es bereits in Schritt 2 wichtig, alle Ziele spezifisch und messbar zu formulieren. Zum Beispiel können Studierende um das Veränderungsziel „Studierende äußern sich positiv über gesunde Snacks“ danach gefragt werden, wie sie verschiedene gesunde Snacks bewerten. In diesem Schritt wird also die Erreichung jeder Stufe auf dem logischen Modell der Veränderung nach und nach evaluiert. Wenn Verhaltensziele nicht erreicht wurden, ist es möglich, dass in

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

Schritt 2 ein wichtiges Handlungsziel nicht adressiert wurde oder dass eine wichtige Determinante nicht identifiziert wurde. Das logische Modell müsste also entsprechend angepasst werden.

Bei der Effektevaluation wird zwischen Wirksamkeit und Effektivität unterschieden. *Wirksamkeit* betrachtet den Effekt der Intervention unter optimalen Bedingungen und *Effektivität* den Effekt unter realen Bedingungen. Bei der Evaluation der Wirksamkeit werden externe Variablen kontrolliert. Also wird eine möglichst repräsentative homogene Stichprobe der Zielgruppe gewählt, die die Intervention von motivierten Umsetzenden unter kontrollierten Bedingungen erhält und bei dieser Stichprobe wird die Wirkung der Intervention evaluiert. Um Effektivität zu beurteilen, wird die Intervention unter realen Bedingungen getestet. Das bedeutet, die Zielgruppe ist heterogener und muss verschiedene Anforderungen balancieren. Die Umsetzenden sind im Alltag mit weiteren Anforderungen konfrontiert und sie müssen häufig Prioritäten setzen, wobei die Umsetzung der Intervention nicht zwangsläufig an vorderster Stelle steht. In der Wirklichkeit spielen demnach weitere konfundierende Faktoren eine Rolle, die die Effektivität der Intervention beeinflussen können (Glasgow et al., 2003). Das bedeutet, dass Interventionen zwar in der Theorie und unter kontrollierten Bedingungen oft wirksam sind, aber in realen Kontexten keine Effektivität gegeben ist. Gründe dafür, warum ein Programm in der Praxis nicht effektiv ist, können in der Prozessevaluation gefunden werden.

Prozessevaluation

Während der Prozessevaluation wird festgestellt, wie gut die Schritte zwei bis vier des Intervention Mappings ausgeführt wurden. Das bedeutet, dass jede Annahme, die während der Planung des Programms gemacht wurde, erneut geprüft wird. Hierfür kann auf das logische Modell der Intervention zurückgegriffen werden (siehe Abbildung 4.4). Ein starker Fokus liegt dabei auf der Umsetzungsgenauigkeit und Reichweite des Programms. Wichtige Komponenten einer Prozessevaluation sind 1. der Kontext, 2. die Reichweite, 3. das Ausmaß, in dem das Programm umgesetzt wurde, 4. das Ausmaß, in dem das Programm empfangen wurde, 5. die Umsetzungsgenauigkeit, 6. die Gesamtumsetzung und 7. das Anwerben von Teilnehmenden:

1. Der *Kontext* bezeichnet Aspekte des weiteren sozialen Umfelds, die die Umsetzung des Programms beeinflussen. Zum Beispiel könnte festgestellt werden, dass Eltern aus religiöser Überzeugung nicht mit ausführlicher Sexualaufklärung in der Schule einverstanden sind.
2. Die *Reichweite* des Programms untersucht, welcher Anteil der Zielgruppe das Programm letztendlich erhalten hat. Zum Beispiel werden über schulbasierte Programme durch die Schulpflicht fast alle Kinder und Jugendliche im Schulalter erreicht.
3. Das *Ausmaß, in dem das Programm umgesetzt wurde*, beschäftigt sich mit der Frage, in welchem Umfang die Einheiten des Programms durchgeführt wurden. Das heißt, Erzieher:innen, die zum Beispiel das Programm „Komm mit in das gesunde Boot" durchführen (vgl. Abschnitt 4.5), könnten ausschließlich Bewegungskarteikarten umsetzen, aber die Ernährungseinheiten aussparen.
4. Das *Ausmaß, in dem das Programm empfangen wurde*, weist darauf hin, in welchem Umfang die Zielgruppe das Programm tatsächlich absolviert hat. Beispielsweise sind Programme mit einer hohen Abbruchquote oder Fehlzeiten weniger effektiv, da ein großer Teil der Zielgruppe nicht das komplette Programm absolviert.
5. *Umsetzungsgenauigkeit* drückt aus, inwiefern das Programm wie von den Entwickler:innen geplant umgesetzt wird. Zum Beispiel könnten Umsetzende Rollenspiele auf eine ungeeignete Art abwandeln, sodass die Parameter der Methode letztendlich nicht mehr gegeben sind oder sodass nicht mehr alle Handlungsziele eingeschlossen sind.

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

6. Die *Gesamtumsetzung* stellt eine Gesamtbewertung dar, inwiefern das Programm umgesetzt wurde.
7. Mit dem *Anwerben von Teilnehmenden* wird der Ansatz beschrieben, wie Teilnehmende angeworben wurden. Zum Beispiel können sie gezielt persönlich eingeladen worden sein, über eine Zeitungsanzeige zum Programm gekommen sein, oder die Teilnahme könnte im schulischen Rahmen verpflichtend gewesen sein. Tabelle 4.3 illustriert die einzelnen Komponenten der Prozessevaluation am Beispiel einer computergesteuerten Telefonintervention, die das Wahrnehmen von Vorsorgeuntersuchungen zu kolorektalen Tumoren bei Veteran:innen stärken soll.

Tabelle 4.3

Indikatoren der Prozessevaluation und Methoden zur Messung am Beispiel einer computergesteuerten Telefonintervention zur Vorsorge von kolorektalen Tumoren bei Kriegsveteran:innen

Komponente	Indikator	Methoden zur Messung
1. Kontext	• Veränderungen in den Richtlinien für Vorsorgeuntersuchungen für kolorektale Tumore bei Veteran:innen oder dem Zugang zu Gesundheitsvorsorge für Veteran:innen • Die organisatorische Kapazität der Veteran:innenverwaltung • Das Ausmaß, in dem Veteran:innen weiteren Programmen zur Vorsorge kolorektaler Tumore ausgesetzt sind	• Kommunikation mit Mitarbeiter:innen der Veteran:innenverwaltung • Nachverfolgung der Richtlinien für Vorsorgeuntersuchungen für kolorektale Tumore bei Veteran:innen und der Nachfrage für Vorsorgeuntersuchungen sowie der Fähigkeit der Veteran:innenverwaltung diese Nachfragen abzudecken • Überprüfung weiterer Programme, Materialien und Richtlinien der Veteran:innenverwaltung mit dem Ziel Vorsorgeuntersuchungen zu fördern
2. Reichweite	• Anteil der Zielgruppe, der das Programm genutzt hat	• Projektdokumentation während der Durchführung
3. Ausmaß, in dem das Programm durchgeführt wurde	• Aktualisierte Liste der Telefonnummern und Länge der abgeschlossenen Anrufe und Auffrischungstermine	• Projektdokumentation während der Durchführung, insbesondere Checkliste für telefonische Beratende und Reporte der telefonischen Beratenden
4. Ausmaß, in dem das Programm empfangen wurde	• Anteil der Zielgruppe, der anruft, um weiterführendes Material anzufragen • Aufmerksamkeit, Erinnerung, Verständnis und Glaubwürdigkeit	• Dokumentationsmaterial der Hotline • Erinnerung und Reaktion der Teilnehmenden auf das Programm • Interviews mit einer randomisierten Stichprobe, die kolorektale Vorsorgeuntersuchungen wahrnehmen oder nicht wahrnehmen
5. Umsetzungs-genauigkeit	• Ausmaß, in dem die Nachricht mit theoretischen Methoden, praktischen Anwendungen und Determinanten übereinstimmt • Passung zwischen Nachricht und Veränderungsphase	• Narrative Analyse der Nachrichtenkonzepte gegenüber den Matrizen der Veränderungsziele, Skripte für die Intervention und Flow-Charts, Checklisten und Transkripte der Gespräche

Anmerkung. Nach Bartholomew Eldredge et al., 2016, S. 554

4.7.2 Evaluationsdesign

Eine wichtige Entscheidung bei der Evaluation eines Programms ist die Auswahl des Evaluationsdesigns. Hierbei haben Entwickler:innen die Wahl zwischen qualitativen, quantitativen und gemischten Designs. Grundsätzlich kommen alle in der Gesundheitspsychologie üblichen Forschungsdesigns in Frage (siehe auch Kurs 2, Kapitel 3 „Forschungsmethoden in der Gesundheitspsychologie"). Mögliche qualitative Methoden beinhalten Interviews, Fokusgruppen, Fallstudien, Beobachtung und offene Fragestellungen in Fragebögen. Als quantitative Methoden kommen zum Beispiel Fragebögen mit Antwortskalen oder Checklisten zur Beobachtung in Frage. Unabhängig von der gewählten Methode muss selbstverständlich auf Reliabilität und Validität geachtet werden.

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

Um Effekte zu testen, ist ein Prätest, der die Ausprägung der Programmziele vor der Intervention misst, unverzichtbar. Dies wird anschließend mit den Ergebnissen des Posttestes verglichen. Um zu untersuchen, wie lange es dauert, bis eine Veränderung eintritt, können gelegentlich Zwischenmessungen durchgeführt werden. Da eine Veränderung über einen gewissen Zeitraum nicht zwangsläufig auf die Intervention zurückzuführen ist, sondern möglicherweise andere Faktoren eine Rolle spielen können, ist eine Kontrollgruppe notwendig. Das bedeutet, dass eine Gruppe, die am Programm teilnimmt, vor und nach der Teilnahme mit einer vergleichbaren Gruppe, die nicht am Programm teilnimmt, verglichen werden muss. Optimal ist also ein experimentelles Design mit randomisierter Zuteilung zur Interventions- und Kontrollgruppe (siehe Kurs 2, Kapitel 3 „Forschungsmethoden in der Gesundheitspsychologie"). In Bezug auf Gesundheitsinterventionen ist randomisierte Zuteilung einzelner Personen häufig jedoch nicht möglich, da sich diese Art von Programmen innerhalb von Organisationseinheiten abspielen. Innerhalb einer Schule ist es beispielsweise unmöglich, einzelne Schüler:innen randomisiert der Interventions- beziehungsweise Kontrollgruppe zuzuordnen. Jedoch ist in diesem Fall randomisierte Zuteilung von Organisationseinheiten möglich (Cluster-Randomisierung). So kann eine bestimmte Schule an der Intervention teilnehmen, wohingegen eine andere der Kontrollgruppe zugeordnet wird und somit die Intervention nicht oder zu einem späteren Zeitpunkt erhält (Wartelisten-Kontrollgruppendesign). Notfalls kann auf ein quasi-experimentelles Design ausgewichen werden, bei dem zwei möglichst ähnliche Gruppen verglichen werden. In dem Fall muss jedoch berücksichtigt werden, dass die Gruppen nie komplett und auf alle Charakteristika bezogen vergleichbar sind. Häufig möchten Entwickler:innen herausfinden, ob ihre Intervention effektiver ist als die Standardbetreuung. In diesem Fall kann die Vergleichsgruppe eine Gruppe sein, die die Standardbetreuung erhält.

4.8 Dokumentation der Interventionsentwicklung

Evidenzbasierte Interventionen haben das Potenzial, gleichermaßen zu Wissenschaft und Praxis beizutragen. Sie können Wissen über Methoden zur Verhaltensänderung generieren, potenzielle Moderatoren (oder Wirkparameter) identifizieren und sie können eine Grundlage für weitere Interventionen bilden. Das ist jedoch nur möglich, wenn sie transparent gestaltet und gut dokumentiert sind. Unglücklicherweise vernachlässigen viele Interventionsentwickler:innen die genaue Dokumentation und die Darstellung der aktiven Komponenten (Johnston, 2014; Michie et al., 2009). Hier birgt Intervention Mapping einen weiteren Vorteil. Es bietet eine Grundlage und einheitliche Terminologie für die Dokumentation der Schlüsselkomponenten von Interventionen. Idealerweise werden die Ergebnisse jedes Schrittes festgehalten, mindestens aber die theoretischen Grundlagen und Methoden sowie praktischen Anwendungen und wie genau diese Determinanten das Verhalten beeinflussen. Dazu bildet das logische Modell der Intervention eine angemessene Grundlage, da hier alle theoretischen Annahmen, die der Intervention zugrunde liegen (die Theorie der Veränderung), übersichtlich dargestellt werden. Diese Transparenz in der Entwicklung ermöglicht Außenstehenden Replikation, Validierung und Bewertung der Effekte. Somit kann sie mit anderen evidenzbasierten Interventionen verglichen werden sowie als Grundlage für neue evidenzbasierte Interventionen dienen und an andere Zielgruppen und Kontexte angepasst werden. Dazu muss die Situation der ursprünglichen Zielgruppe mit der Situation der neuen Zielgruppe verglichen und es müssen gegebenenfalls Determinanten, Methoden oder praktische Anwendungen angepasst werden (Kok et al., 2016).

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440